Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 21–24 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Werte in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und Frankls Wertkategorien

Konvergenzen und Differenzen zweier Wertkonzeptionen

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Werte nehmen sowohl in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) als auch in der Logotherapie eine zentrale Stellung ein. In der ACT gelten Werte als frei gewählte, verbal konstruierte Qualitäten fortlaufenden Handelns, die engagiertes Verhalten ausrichten und der psychologischen Flexibilität eine Richtung geben. Viktor E. Frankl unterschied dagegen schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte, die nach seinem Verständnis nicht erfunden, sondern in der jeweiligen Situation gefunden werden. Der vorliegende theoretische Beitrag vergleicht beide Konzeptionen systematisch. Herausgearbeitet werden Konvergenzen, etwa die Unterscheidung zwischen Werten und Zielen, die Betonung von Handlung und Engagement, die Bedeutung von Werten im Umgang mit unvermeidlichem Leid sowie die Funktion von Werten als Gegengewicht zu einer ausschließlich symptomorientierten Therapie. Zugleich werden grundlegende Differenzen beleuchtet, die sich aus unterschiedlichen philosophischen Hintergründen ergeben: dem funktionalen Kontextualismus der ACT einerseits und der phänomenologisch-personalistischen Anthropologie Frankls andererseits. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, ob Werte gewählt oder entdeckt werden, sowie dem Status der Einstellungswerte. Der Beitrag schließt mit Überlegungen dazu, wie beide Traditionen voneinander lernen können, ohne ihre jeweiligen Prämissen zu verwischen.

Schlüsselwörter: Akzeptanz- und Commitment-Therapie · Werte · Logotherapie · Einstellungswerte · Psychologische Flexibilität

ABSTRACT

Values occupy a central position in both acceptance and commitment therapy (ACT) and logotherapy. In ACT, values are understood as freely chosen, verbally constructed qualities of ongoing action that guide committed behavior and give direction to psychological flexibility. Viktor E. Frankl, in contrast, distinguished creative, experiential, and attitudinal values, which, in his view, are not invented but discovered in the respective situation. This theoretical paper systematically compares the two conceptions. It identifies convergences, such as the distinction between values and goals, the emphasis on action and engagement, the significance of values in dealing with unavoidable suffering, and the function of values as a counterweight to an exclusively symptom-oriented therapy. At the same time, it highlights fundamental differences that arise from distinct philosophical backgrounds: the functional contextualism of ACT on the one hand and Frankl's phenomenological and personalist anthropology on the other. Particular attention is paid to the question of whether values are chosen or discovered and to the status of attitudinal values. The paper concludes with reflections on how both traditions can learn from each other without blurring their respective premises.

Keywords: acceptance and commitment therapy · values · logotherapy · attitudinal values · psychological flexibility

1 Einleitung

In der Psychotherapie der vergangenen Jahrzehnte hat der Begriff der Werte eine bemerkenswerte Renaissance erfahren. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), die Werte als einen ihrer sechs Kernprozesse ausweist (Hayes et al., 1999, 2012). Für Leserinnen und Leser, die mit der Logotherapie vertraut sind, ist diese Entwicklung von besonderem Interesse, denn Frankl hatte bereits Jahrzehnte zuvor eine Wertlehre entwickelt, die im Zentrum seines psychotherapeutischen Ansatzes steht (Frankl, 1946).

Die naheliegende Vermutung, es handle sich um zwei Varianten derselben Grundidee, greift jedoch zu

kurz. Beide Traditionen sind in unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen und anthropologischen Kontexten entstanden, und dieselben Begriffe tragen in ihnen teils verschiedene Bedeutungen. Der vorliegende Beitrag vergleicht beide Konzeptionen, um Gemeinsamkeiten präzise zu benennen und Unterschiede nicht vorschnell einzuebnen.

Der Vergleich gliedert sich in vier Schritte. Zunächst wird das Wertekonzept der ACT in seinen theoretischen Zusammenhang gestellt, anschließend Frankls Wertlehre skizziert. Darauf aufbauend werden Konvergenzen und Differenzen herausgearbeitet. Abschließend wird erörtert, welche Folgerungen sich für Praxis, Diagnostik und Forschung ergeben. Der Beitrag beschränkt sich dabei auf die konzeptuelle Ebene und trifft keine Aussagen über die vergleichende Wirksamkeit beider Ansätze.

2 Werte in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie

Die ACT versteht sich als Anwendung des funktionalen Kontextualismus und der Bezugsrahmentheorie, eines verhaltensanalytischen Ansatzes zur Erklärung menschlicher Sprache und Kognition (Hayes et al., 2001). Psychisches Leiden entsteht nach diesem Verständnis wesentlich durch psychologische Inflexibilität, also durch die Dominanz starrer verbaler Regeln, erlebnisvermeidender Strategien und eine Verengung des Verhaltensrepertoires (Hayes et al., 2006). Psychologische Flexibilität gilt umgekehrt als grundlegender Aspekt psychischer Gesundheit (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Werte werden in der ACT als frei gewählte, verbal konstruierte Konsequenzen fortlaufender, sich entwickelnder Handlungsmuster beschrieben, die als Verstärker wirken und dem Handeln Richtung verleihen (Hayes et al., 2012). Wesentlich ist die Unterscheidung von Werten und Zielen: Ziele können erreicht und abgeschlossen werden, Werte dagegen gleichen einer Himmelsrichtung, an der man sich orientiert, ohne je anzukommen. Werte sollen zudem nicht aus Pflicht, sozialem Druck oder dem Wunsch nach Schmerzvermeidung abgeleitet, sondern als persönlich bedeutsam erlebt werden. Für die Erfassung wertorientierten Handelns wurden eigene Instrumente entwickelt, etwa der Valued Living Questionnaire (Wilson et al., 2010).

In der therapeutischen Arbeit werden Werte in der ACT häufig über erlebnisorientierte Übungen erschlossen, etwa durch die Vorstellung der eigenen Trauerfeier oder durch die Frage, wofür man im Leben stehen möchte (Hayes et al., 1999). Wertklärung ist dabei kein einmaliger Akt, sondern ein fortlaufender Prozess, der eng mit engagiertem Handeln verknüpft ist. Zugleich wird darauf geachtet, Werte nicht als neue starre Regeln zu etablieren, die ihrerseits zu Inflexibilität führen könnten.

3 Frankls Wertkategorien

Frankl unterschied drei Hauptwege, auf denen Menschen Sinn verwirklichen können (Frankl, 1946, 1955). Schöpferische Werte verwirklichen sich in dem, was ein Mensch der Welt gibt, etwa durch Arbeit oder Gestaltung. Erlebniswerte verwirklichen sich in dem, was ein Mensch von der Welt empfängt, etwa in der Begegnung mit Natur, Kunst oder einem anderen Menschen. Einstellungswerte schließlich verwirklichen sich in der Haltung, die ein Mensch gegenüber einem unabänderlichen Schicksal, insbesondere gegenüber unvermeidbarem Leid, einnimmt.

Für Frankl werden Sinn und Werte nicht erfunden, sondern gefunden. Sinn ist nach seinem Verständnis jeweils situationsbezogen und richtet sich als Anruf an die einzelne Person, die darauf in Verantwortung antwortet (Frankl, 1969). Das Gewissen fungiert dabei als „Sinn-Organ“, das den einmaligen Sinn einer Situation erspüren kann. Diese Konzeption ist eingebettet in eine Anthropologie, die eine geistige Dimension des Menschen annimmt und Selbsttranszendenz – die Ausrichtung auf etwas oder jemanden jenseits der eigenen Person – als Kennzeichen menschlicher Existenz betrachtet.

Die Wertkategorien sind bei Frankl nicht im Sinne einer starren Hierarchie zu verstehen; gleichwohl hat er den Einstellungswerten eine besondere Würde zugesprochen, weil sie auch dort noch verwirklicht werden können, wo schöpferische und erlebnisbezogene Möglichkeiten erschöpft sind. Darin liegt die Pointe seiner These von der unbedingten Sinnhaftigkeit des Lebens: Solange ein Mensch lebt, bleibt ihm zumindest die Möglichkeit, zu seinem Schicksal Stellung zu nehmen (Frankl, 1946).

4 Konvergenzen

Trotz unterschiedlicher Herkunft lassen sich mehrere Konvergenzen benennen. Erstens betonen beide Ansätze die Unterscheidung zwischen einer übergreifenden Richtung und konkreten Zielen. Frankls Rede vom Sinn als Aufgabe, die sich in jeder Situation neu stellt, und die ACT-Metapher der Himmelsrichtung verweisen gleichermaßen darauf, dass Werte nicht abgehakt werden können. Zweitens legen beide Traditionen den Schwerpunkt auf

Handeln und Engagement statt auf bloße Einsicht. Drittens sehen beide in Werten ein Gegengewicht zu einer Therapie, die sich ausschließlich an der Reduktion von Symptomen orientiert.

Am auffälligsten ist die Nähe im Umgang mit unvermeidlichem Leid. Die ACT lädt dazu ein, schmerzhafte innere Erfahrungen nicht zu bekämpfen, sondern sie im Dienst wertgeleiteten Handelns anzunehmen. Frankls Einstellungswerte zielen auf eine verwandte Haltung: Wo eine Situation nicht geändert werden kann, bleibt die Freiheit, zu ihr Stellung zu nehmen. In beiden Fällen wird die Bewältigung von Leid nicht als dessen Beseitigung, sondern als Veränderung der Beziehung zu ihm verstanden.

5 Differenzen

Die grundlegendste Differenz betrifft den Status von Werten. In der ACT sind Werte gewählt; ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer Funktion für das Handeln einer Person, und der funktionale Kontextualismus verzichtet bewusst auf ontologische Aussagen darüber, ob es Werte unabhängig vom Menschen gibt (Hayes, 2004). Für Frankl dagegen sind Werte und Sinn nicht beliebig wählbar, sondern haben einen Aufforderungscharakter, der dem Menschen von außen entgegentritt. Diese Differenz ist nicht bloß terminologisch: Sie hat Folgen für die Frage, ob eine Therapeutin oder ein Therapeut Werte eines Klienten in Frage stellen darf, und für die Bedeutung von Verantwortung und Gewissen.

Eine zweite Differenz betrifft die Einstellungswerte. In der ACT ist Akzeptanz ein Prozess, der wertgeleitetes Handeln ermöglicht, aber selbst kein Wert. Bei Frankl hingegen kann die Haltung gegenüber dem Leid selbst sinnvoll sein – auch dann, wenn keine weiteren Handlungsmöglichkeiten bestehen. Diese Position erhält besonderes Gewicht in Situationen, in denen der Handlungsspielraum stark eingeschränkt ist, etwa bei schwerer Krankheit am Lebensende.

Eine dritte Differenz betrifft die Rolle der Selbsttranszendenz. Die ACT kennt mit dem Selbst-als-Kontext eine Perspektive, die über die Identifikation mit Selbstkonzepten hinausführt. Frankls Selbsttranszendenz meint jedoch etwas anderes: die Hinwendung zu einem Sinn oder einem anderen Menschen jenseits des eigenen Erlebens. Auch die Existenzanalyse hat die personale Stellungnahme als eigenständige Dimension betont (Längle, 2013).

Eine vierte Differenz betrifft das Verhältnis von Sprache und Sinn. In der ACT wird Sprache als zweischneidig betrachtet: Die Fähigkeit, Bezugsrahmen zu bilden, ermöglicht Werte und Zukunftsorientierung, ist aber zugleich Quelle von Grübeln, Selbstbewertung und Erlebnisvermeidung (Hayes et al., 2001). Frankl hingegen betrachtet die geistige Dimension nicht primär unter dem Aspekt ihrer Risiken, sondern als Quelle von Freiheit und Verantwortung. Die Skepsis der ACT gegenüber der Dominanz verbaler Regeln findet in der Logotherapie kein unmittelbares Gegenstück, wenngleich Frankls Kritik an der Hyperreflexion in eine verwandte Richtung weist.

6 Schlussfolgerungen

Der Vergleich zeigt, dass ACT und Logotherapie in ihrer praktischen Ausrichtung erstaunlich nahe beieinanderliegen, in ihren philosophischen Begründungen jedoch deutlich divergieren. Für die Praxis kann dies bereichernd sein: Die ACT bietet eine Vielzahl erprobter Übungen zur Klärung von Werten und zur Förderung psychologischer Flexibilität; die Logotherapie bietet eine differenzierte Sprache für den Umgang mit unabänderlichem Leid und für die Frage, worauf sich ein Mensch jenseits seiner selbst ausrichtet. Für die Forschung ergibt sich die Aufgabe, die Unterschiede in den Wertkonzeptionen so zu operationalisieren, dass ihre jeweiligen Beiträge zur Veränderung empirisch unterscheidbar werden. Eine eklektische Vermischung ohne Reflexion der Prämissen wäre dagegen weder der einen noch der anderen Tradition dienlich.

Für die Messung ergeben sich daraus unterschiedliche Anforderungen. Instrumente aus der ACT-Tradition erfassen typischerweise, wie wichtig einer Person bestimmte Lebensbereiche sind und wie konsistent sie im Einklang mit diesen handelt (Wilson et al., 2010). Logotherapeutische Konzepte wie die Verwirklichung von Einstellungswerten lassen sich mit solchen Instrumenten nur unzureichend abbilden, da sie gerade auch Situationen betreffen, in denen wertkonsistentes Handeln im üblichen Sinn kaum möglich ist. Hier besteht Entwicklungsbedarf für die Diagnostik.

Literatur

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1955). The doctor and the soul: An introduction to logotherapy. Knopf.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639–665.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (Eds.). (2001). Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865–878.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60(2), 249–272.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Values in Acceptance and Commitment Therapy and Frankl's Categories of Values: Convergences and Differences Between Two Conceptions of Values. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 21–24.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.